



Chaire de recherche en exploitation
des ressources informationnelles



École nationale
d'administration publique

Information, confiance et acceptabilité sociale du partage des renseignements de santé : éléments de conception d'une politique publique

**École d'été interdisciplinaire en numérique de
la santé**

Sherbrooke, 26 mai 2026

Daniel J. Caron Ph D

Professeur

Chercheur et Fellow du CIRANO

Membre chercheur associé, Observatoire international sur les impacts sociétaux de
l'IA et du numérique (OBVIA)

Adjunct Professor, SPPA, Carleton University

Titulaire de la Chaire de recherche en exploitation des ressources informationnelles

www.crieri.org

École nationale d'administration publique

Plan de la présentation

Introduction

Éléments de politique publique:
données de santé
cohérence

Information et organisation

Environnement numérique

Résultats de recherches: perspectives et
pratiques

Politique publique dans un environnement
désectorisé et numérique

Conclusion

L'univers numérique pose des contraintes au développement d'un cadre de politique approprié:

- compréhension commune;
- acceptabilité sociale;
- protection;
- plusieurs acteurs (privés et publics)
- objectifs fragmentés parmi les créateurs et les utilisateurs, etc.

Il révèle en même temps de multiples possibilités:

- plus grande efficacité par la valorisation de l'information;
- prise en charge plus éclairée;
- responsabilisation des usagers;
- Recherches – volet administratif et clinique, etc.

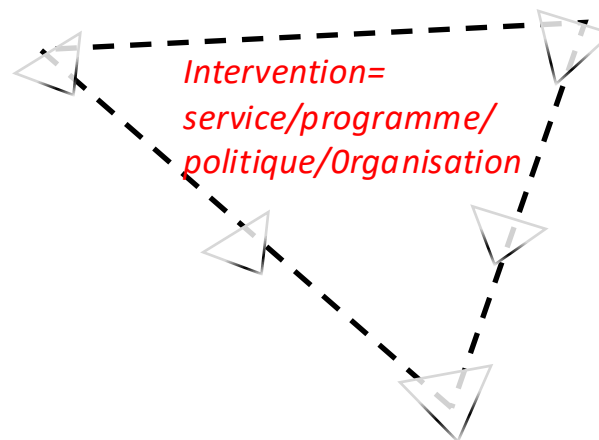
Les *pratiques* informationnelles et les *politiques* informationnelles – substantielles et institutionnelles- devront *intégrer* ces potentiels et ces contraintes pour assurer une cohérence d'ensemble afin de vivre dans l'univers numérique.

1. Le contenu

La recherche fondamentale
(production de connaissances) : en continu

e.g. enquêtes sur
l'acceptabilité sociale,
recherche sur le routage de
l'information, pratiques et
normes professionnelles,
obligations légales, etc.

L'évaluation de politiques et de programmes (production de
connaissances) : à intervalles



e.g. mesurer la satisfaction
des patients partenaires à la
suite de l'instauration de
programmes de partenariat

L'analyse de politiques: l'arbitrage

e.g. qui fait quoi entre le privé et le
public, entre l'accès aux données et
leur protection



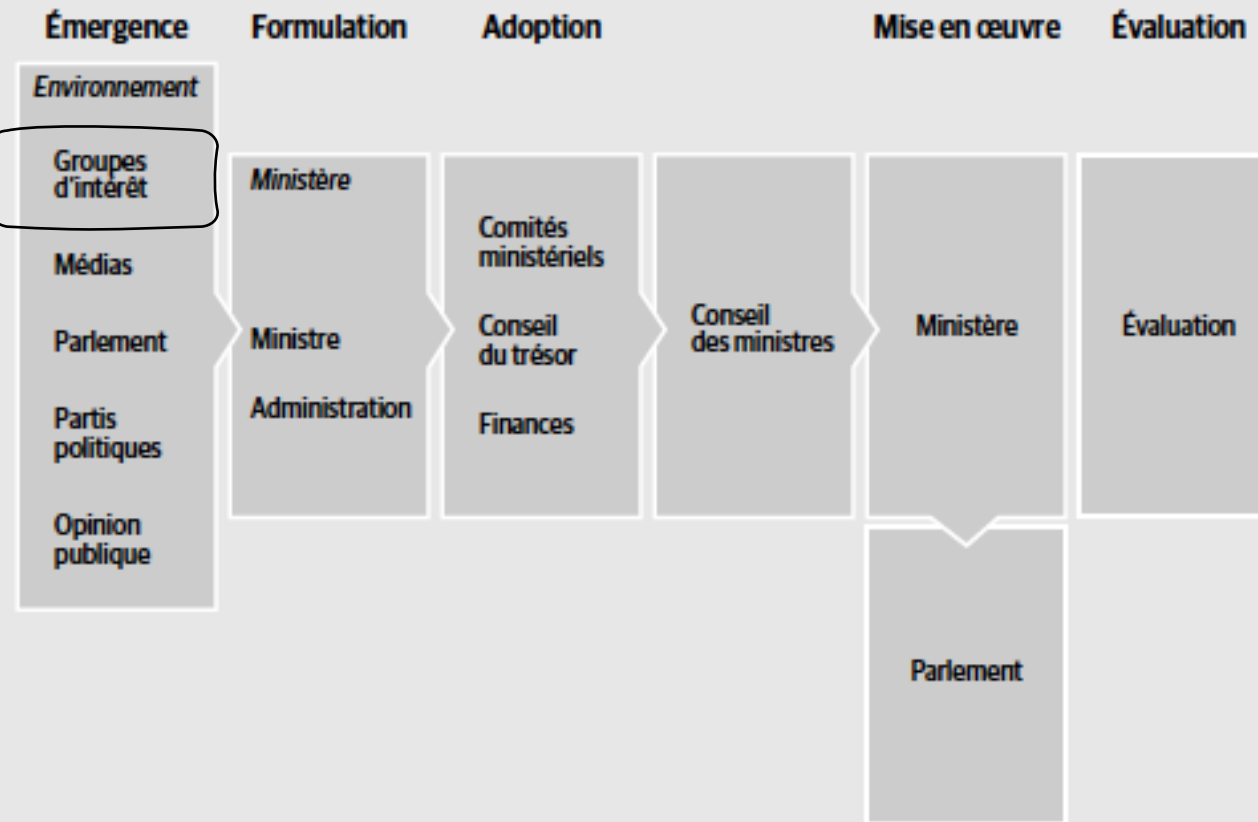
*Les politiques et les ajustements
aux politiques*

Éléments de politique publique

2. Le processus

cliniciens,
usagers,
chercheurs,
administrateurs,
assureurs,
fournisseurs, etc

FIGURE 11.1 / Le cycle de vie des politiques publiques



Source: Inspiré de Anderson (1975).

Are We Living Under 'Technofeudalism'?

Malcolm Harris Oct. 28, 2022



fragmente sur fond de durabilité,
d'efficacité globale (pérennité i.e. des
politiques publiques interconnectées)

47. Malgré l'article 1, le médecin qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement (2024-07-11), exerce la profession peut continuer de constituer, de tenir, de détenir, de maintenir et de conserver ses dossiers cliniques sur support papier jusqu'au 31 décembre 2026. À compter du 1^{er} janvier 2027, toute nouvelle inscription à un dossier clinique est consignée sur un support technologique. Le médecin peut toutefois conserver sur support papier la partie du dossier constituée avant cette date.

Toutefois, le médecin qui exerce la profession depuis 35 ans et qui exerce seul peut continuer de constituer, de tenir, de détenir, de maintenir et de conserver ses dossiers cliniques sur support papier jusqu'au 31 décembre 2029. À compter du 1^{er} janvier 2030, toute nouvelle inscription à un dossier clinique est consignée sur un support technologique. Le médecin peut toutefois conserver sur support papier la partie du dossier constituée avant cette date.

<https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/M-9,%20r.%2020.3.1?&cible=>

Source: Knoepfel P., Larrue C., Varone F.
Analyse et pilotage des politiques publiques,
Verlag Rügger, Zurich, 2006

Qui sont les producteurs et les consommateurs d'informations

Producteur	Consommateur
 Citoyen - q Est la base de l'information - q Soins et services - q Matériel biologique - q Objets connectés	 Citoyen - q Prendre en charge sa santé - q Consulter son dossier ou celui d'un de ses proches - q Participer à des projets de recherche
 Intervenant - q Traitements, actes et suivi du patient – Directement - q Coûts, masse salariale, corridor de services - Indirectement	 Intervenant - q Soins aux patients - q Formation - q Enseignement - q Amélioration de la pratique médicale
 Recherche - q Recherche scientifique - q Nouveaux traitements, technologies et mode d'interventions	 Recherche - q Recherche - q Innovation - q Développement - q Enseignement
 Gestion - q Dépenses - q Gestion des équipements - q Organisation des ressources	 Gestion - q Organisation des soins et des services - q Evaluation et amélioration des programmes - q Soutien à la performance - q Protection de la population – Santé publique

MSSS | Direction générale de la planification stratégique et de la performance

5

Quels sont les enjeux relatifs à l'utilisation des données

Accès, obtention et levées des barrières légales	Utilisation, circulation et partage	Conservation et protection
 Citoyen ❑ Consulter son dossier de santé et ses renseignements	 Citoyen ❑ S'assurer que ses intervenant aient ses renseignements ❑ Partager ses renseignements à un proche désigné ❑ Avoir les outils nécessaires pour consulter ses renseignements ❑ Prendre en charge sa santé	 Citoyen ❑ Être rassuré par la mise en place de mécanismes de sécurité ❑ Pouvoir retirer son consentement si nécessaire ❑ Savoir qui a consulté ses renseignements
 Intervenant ❑ Obtenir les renseignements du patient peu importe où les soins et services ont été prodigués ❑ Permettre l'accès à tous les intervenants prodiguant des soins du patient ❑ Accéder en temps réel aux données	 Intervenant ❑ Avoir les outils nécessaires pour consulter les renseignements concernant son patient ❑ Pouvoir utiliser les données à des fins d'amélioration de la pratique et de la qualité de l'acte	 Intervenant ❑ Maintenir certaines restrictions, notamment concernant des renseignements sensibles.
 Recherche ❑ Accéder aux données dans des délais plus court ❑ Pouvoir réutiliser les données obtenues par consentement pour d'autres recherches similaires ❑ Obtenir les données afin de demeurer compétitif et poser des constats sur le Québec	 Recherche ❑ Utiliser les données pour démarrer des initiatives basées sur l'IA ❑ Être en mesure de partager sécuritairement les données entre certains chercheurs sans distinction de provinces ou de pays	 Recherche ❑ S'assurer que les données qui lui sont transmises ne sont pas détruites après usage
 Gestion ❑ Obtenir les données du secteur privé afin d'avoir un portrait global de l'ensemble des services. ❑ Limiter le nombre de justifications pour obtenir des données et en simplifier le processus d'obtention ❑ Pouvoir obtenir et utiliser des données contenues dans les dossier des usagers pour l'optimisation du parcours de soin ❑ Avoir accès aux données relatives à la pratique médicale et pouvoir, le cas échéant, les partager	 Gestion ❑ Pouvoir utiliser des données pour des fins autres que celles déjà prévues, notamment pour le suivi de programmes ❑ Établir un portrait complet de l'offre de soins ❑ Utiliser les données pour des fins d'amélioration de la performance, d'organisation des soins et services et d'optimisation des services aux citoyens ❑ Valoriser les données collectés sous sa responsabilité ❑ Réaliser des analyses prédictives	 Gestion ❑ S'assurer que ceux qui ont des données soient imputables de leur utilisation (responsabilisation) ❑ Voir à ce que des sanctions soient prévues en cas d'utilisation non-autorisées ou malveillantes ❑ Revoir l'accès et la protection nécessaire à des renseignements sensibles (jeunesse, santé mentale, etc.)

MSSS | Direction générale de la planification stratégique et de la performance

7

Comment est encadré l'utilisation des renseignements

Type d'accès	Lois
 Citoyen q Accès à son dossier	 Citoyen - q LSSS - q LADOPRP - q LPRPSP - q LPCRS
 Intervenant - q Traitements, actes et suivi du patient – Directement - q Coûts, masse salariale, corridor de services - Indirectement	 Intervenant - q LM - q Cor' - q 'r
 Recherche - q Recherche scientifique - q Nouveaux traitements, technologies et mode d'inter	 Recherche - q LSSS - q LADOPRP - q LPRPSP
 Gestion q Mise en œuvre de ses fonction	 Gestion - q LSSSS - q LAM - q LSP - q LADOPRP - q LPRPSP - q LPCRS

MSSS | Direction générale de la planification stratégique et de la performance

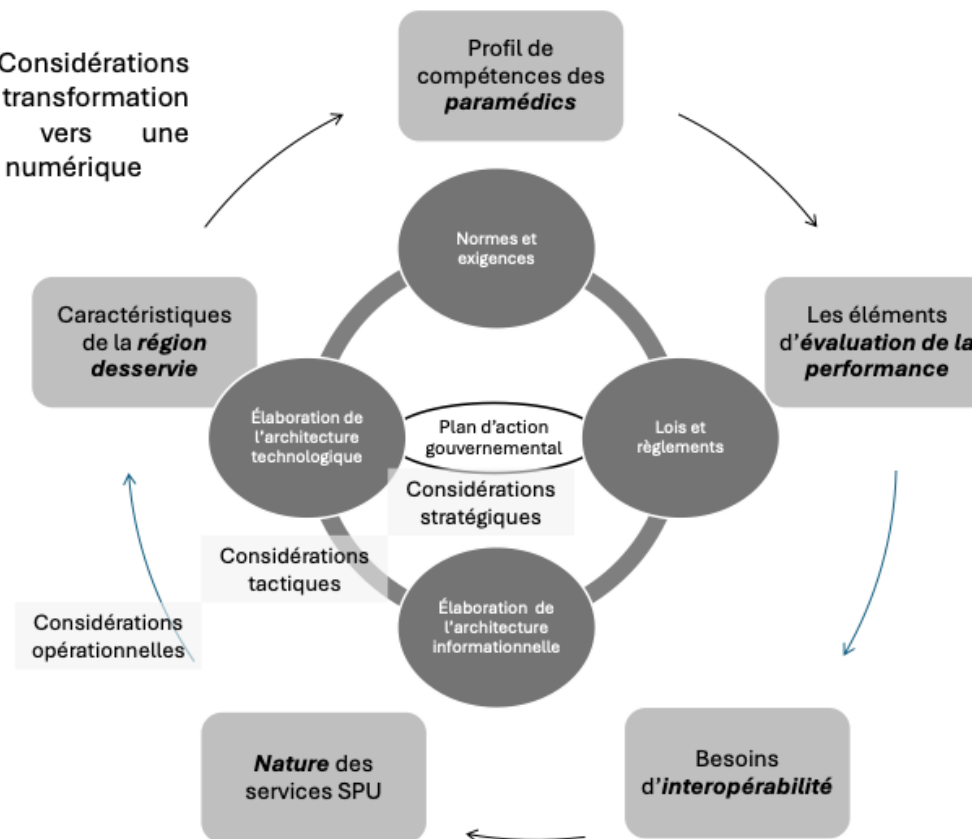
6

Défi: assurer la cohérence

Le cas des services préhospitaliers

Services rendus et services de soutien

Figure 4: Considérations pour une transformation des SPU vers une organisation numérique



<https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2025RP-04>

Les politiques publiques en santé sont cohérentes avec ses politiques administratives

s
é
e

= Services rendus

Éléments de politique publique: besoin de cohérence

Les politiques publiques en santé sont cohérentes entre elles

Exemple du besoin de cohérence

Éléments de politique publique: cohérence ?

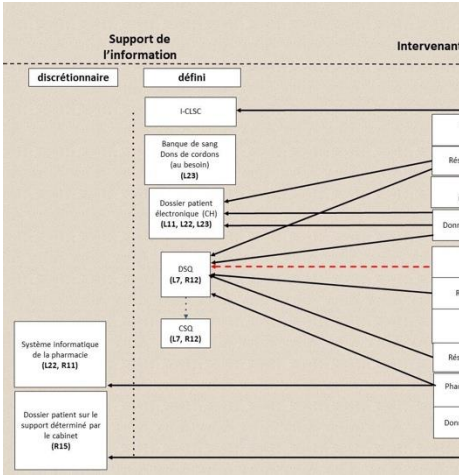


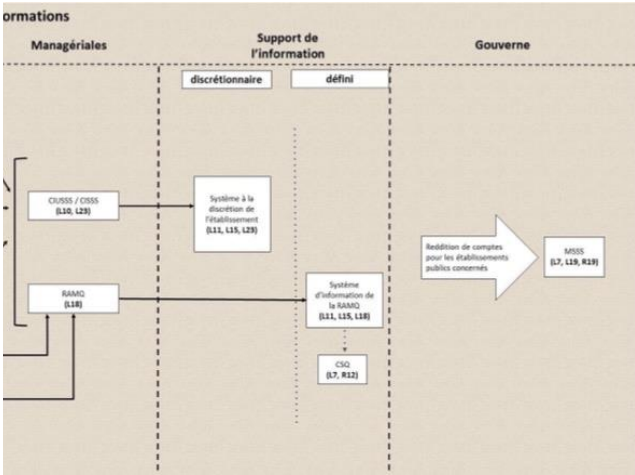
Tableau 1

Professions	médecins	sage-femme	Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugués et familiaux	pharmaciens	optométristes	sexologues	technologues professionnels	Technologistes médicaux	psychologues	technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale	physiothérapeutes	Infirmières et infirmiers	diététistes	ergothérapeutes	inhalothérapeutes	orthophonistes et audiologistes	Obligations
Création d'un dossier du patient																	
Contenu du dossier																	
Propriété du dossier																	
Système informatique																	
Mise à jour du dossier																	
Lieu de conservation																	
Durée de conservation																	
Destruction du dossier																	
Classement des dossiers/ documents																	

avant être transmis au ministre R19

renseignements devant être transmis au ministre R19

16



Caron, D. J. avec la collab. de Lamontagne, R., Drouin, O., Nicolini, V. et Bernardi, S. (2021). [Partage des données en santé au Québec : modélisation et cartographie des trajectoires de partage des données](#). Rapport de recherche. Chaire de recherche en exploitation des ressources informationnelles. Gatineau : École nationale d'administration publique. ISBN : 978-2-89734-058-2 (PDF)

L'information est la
ressource cognitive aux
fondements de la
capacité d'intervention
des acteurs publics et
privés

L'organisation est la
ressource interactive

Elle est la matière première qui
permet l'identification et la
définition politique du problème
public, le programme politico-
administratif pour répondre à ce
problème, le mettre en œuvre et
l'évaluer.

Elle correspond à la qualité de
de l'organisation des structures
administratives et sociétales et
des réseaux de relations entre
les acteurs

« (...) Le succès de la
transformation repose sur
plusieurs facteurs et dépend
largement de la capacité des
organisations à comprendre et
capitaliser sur les
interdépendances entre les
différents acteurs, les systèmes,
les normes et les diverses
exigences cliniques et
administratives (...). »

Caron et al. (2025) Le routage de
l'information médicale et administrative
dans l'univers numérique de la santé et des
services sociaux et le rôle des archivistes
médicaux, CRERI, Cahier de recherche.

L'information et son support ont une capacité structurante quant à la conception de la ressource interactive

Nouvel environnement déséctorisé, numérique

Environnement numérique

Cycles de l'action publique	Régimes					Une sorte de « vérité du monde »
	Régime marchand	Régime de globalisation	Régime de citoyenneté	Régime d'action publique	Référentiel global	
	Cycle libéral industriel	Capitalisme industriel	Régime westphalien	Citoyenneté de classe	État libéral	Référentiel du laissez-faire
	Cycle de l'État-providence	Capitalisme organisé	Régime bipolaire	Citoyenneté sectorielle	État interventionniste	Référentiel keynésien
	Cycle de l'État-entreprise	Capitalisme financier	Mondialisation	Citoyenneté individuelle	État managérial	Référentiel de l'efficience publique
	Cycle de la gouvernance durable	Capitalisme globalisé	Fragmentation	Citoyenneté en réseaux	État déséctorisé	Référentiel de l'efficacité globale

L'évolution de l'environnement mondial:
une perspective d'action publique

Fin XIXe à 1929 et après-guerre
Les Trente glorieuses
Fin des années '80
Aujourd'hui

2. Bruno JOBERT et Pierre MULLER, *L'État en action. Politiques publiques et corporatismes*, Paris : PUF, 1987.

....bienvenue dans la citoyenneté numérique mondialisée du cycle 4...(Muller, p. 110)

Nouvel environnement déséctorisé, numérique

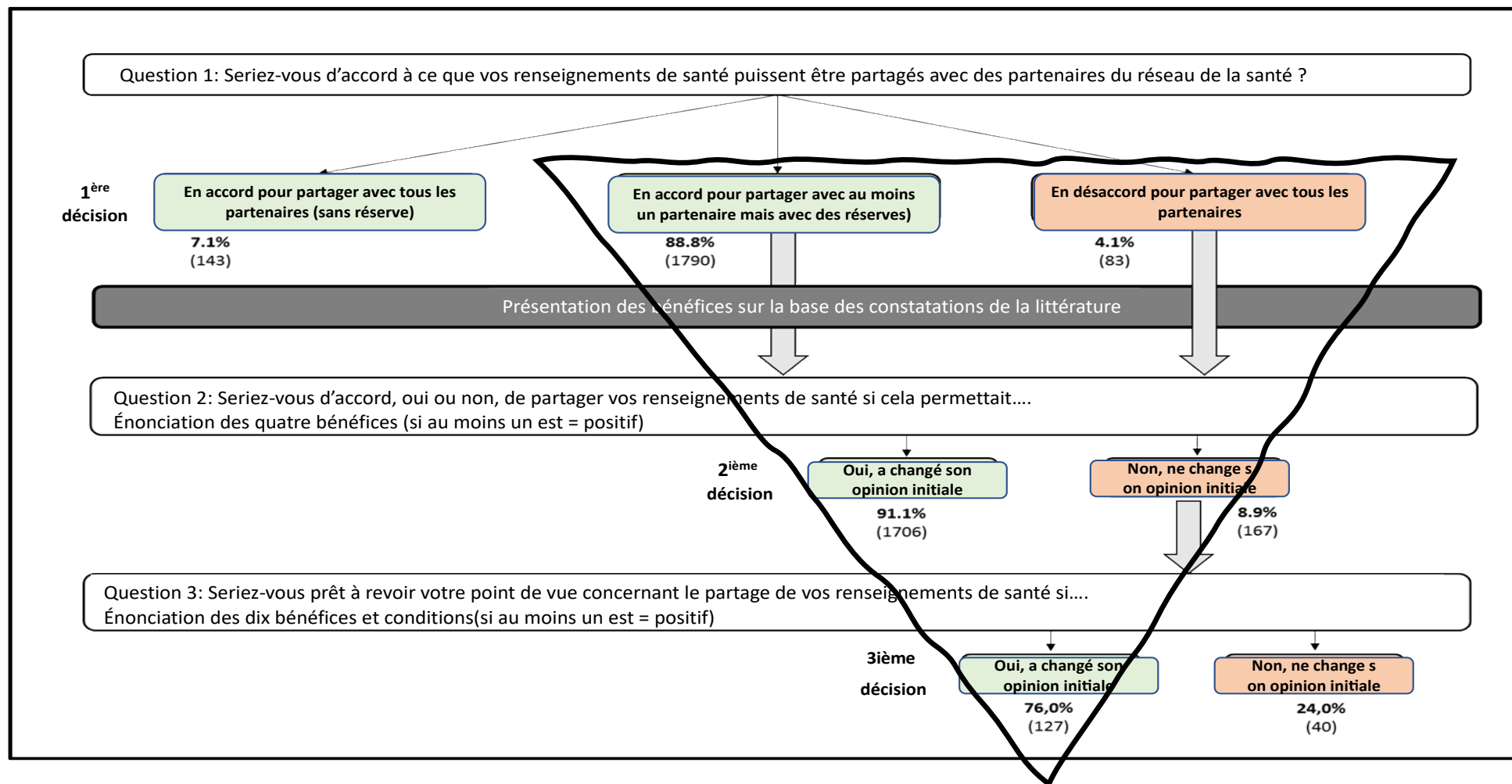
Illustration: le cas de la mesure de la performance de l'action publique

- Premièrement, la performance publique, son sens et sa mesure, est affectée par la place grandissante de l'opinion publique qui s'exprime, mais participe aussi aux débats de manière très active et articulée quant aux choix à faire dans les politiques publiques d'une société. **Le GAP, etc.**
- Deuxièmement, la prestation de services est affectée par les possibilités d'automatisation. Ici, l'enjeu est différent pour l'agent public dont la performance marquée par **Carnet santé Québec** moins à l'aune de ce qu'il fait avec les moyens dont il dispose, mais davantage sur la base des possibilités qu'offrent les technologies.
- Troisièmement, l'automatisation de la mesure de la performance est aussi un enjeu important qui peut mener à des situations indésirables ou créer des externalités négatives. **Le préhospitalier et l'utilisation des ressources**
- Quatrièmement, la dispersion de l'information commune provoquée par l'éclatement des moyens de communication internes peut conduire à une désagrégation de la **Santé Québec** commune essentielle à la performance organisationnelle.

Source: *Bouleversement de l'univers techno-informationnel et mesure de la performance de l'action publique : enjeux et défis* Daniel J. Caron et Vincent Nicolini, ENAP Revue Télescope, Décembre 2023

Degré d'ouverture pour le partage des renseignements de santé (2020)

Résultats de recherches: perspectives et pratiques



Partage des renseignements de santé (2020)

Acceptabilité sociale 2021 (CRERI)

Les résultats montrent que les répondants sont **ouverts à partager voire à changer d'idée** pour plus de partage s'ils y trouvent des bénéfices collectifs et individuels et si les pratiques de partage sont connues et suffisantes

Si l'acceptabilité sociale du partage des données de santé semble possible, elle nécessite donc de se faire à l'intérieur de certains paramètres.

Une de ces conditions de partage est une garantie de sécurité et d'anonymisation des données.

Acceptabilité sociale? Contrat social? Démocratie sanitaire?

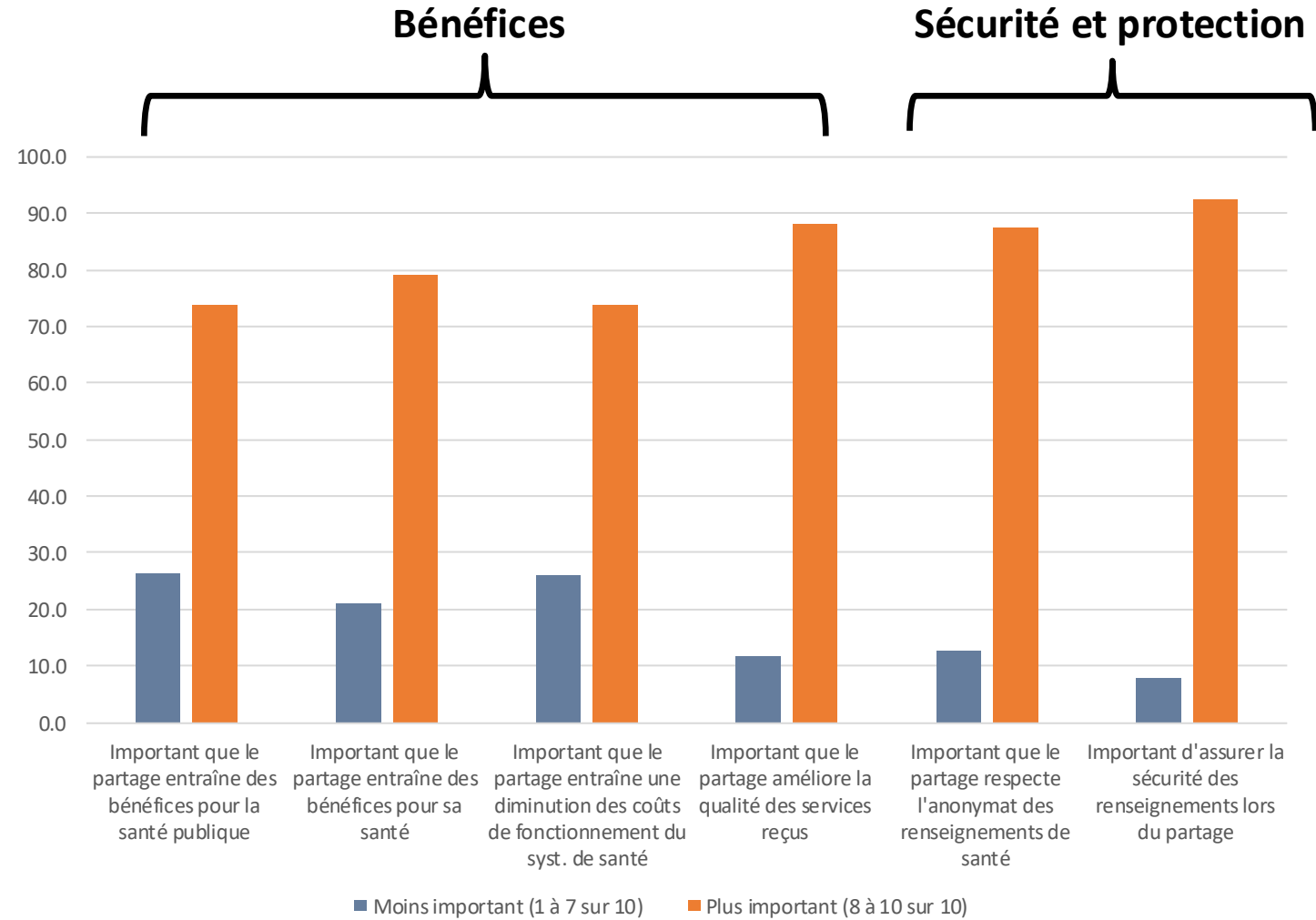
	Gains réalisés sur la base de meilleures connaissance et l'ajout de conditions dans le partage		
	Gains possibles	Gains réels	%
1 ^{ère} itération: présentation des bénéfices	1873	1707	91,7
2 ^{ième} itération: présentation de conditions	166	126	75,9
Total	1873	1833	97,8

Caron et al., (2023) Policy approaches for increasing participation with personal health information and data sharing (HIDS), Canadian Health Policy Journal, (DOI <https://doi.org/10.54194/XYCP5241>)

Question: quelles implications?

Conditions de partage et d'utilisation

Distribution (%) des participants le niveau d'importance accordé à certains aspects du partage de renseignements de santé - pour ceux qui sont d'accord ou prêts à changer de point de vue



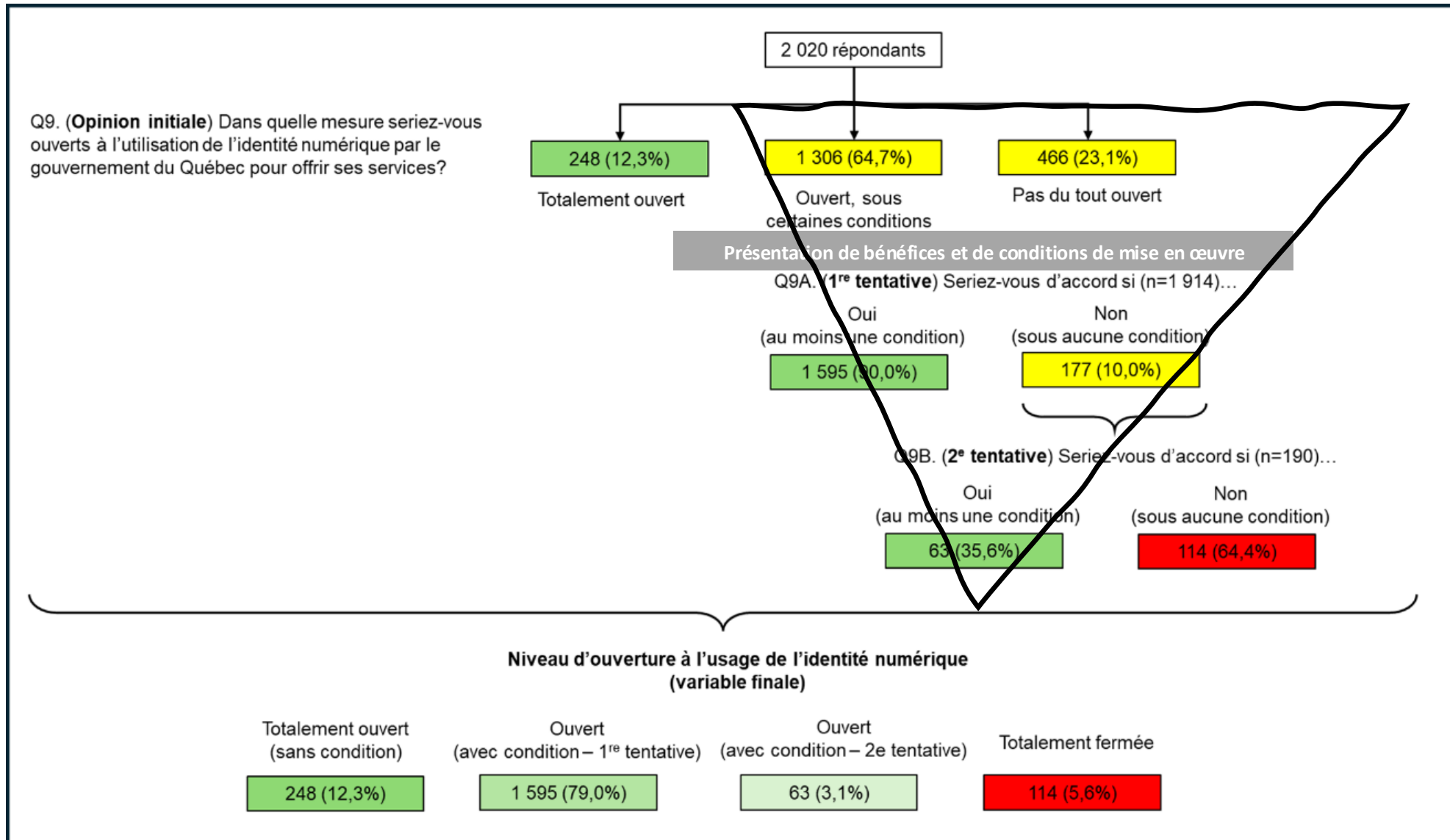
Résultats de recherches: perspectives et pratiques

Partage des renseignements de santé (2020)

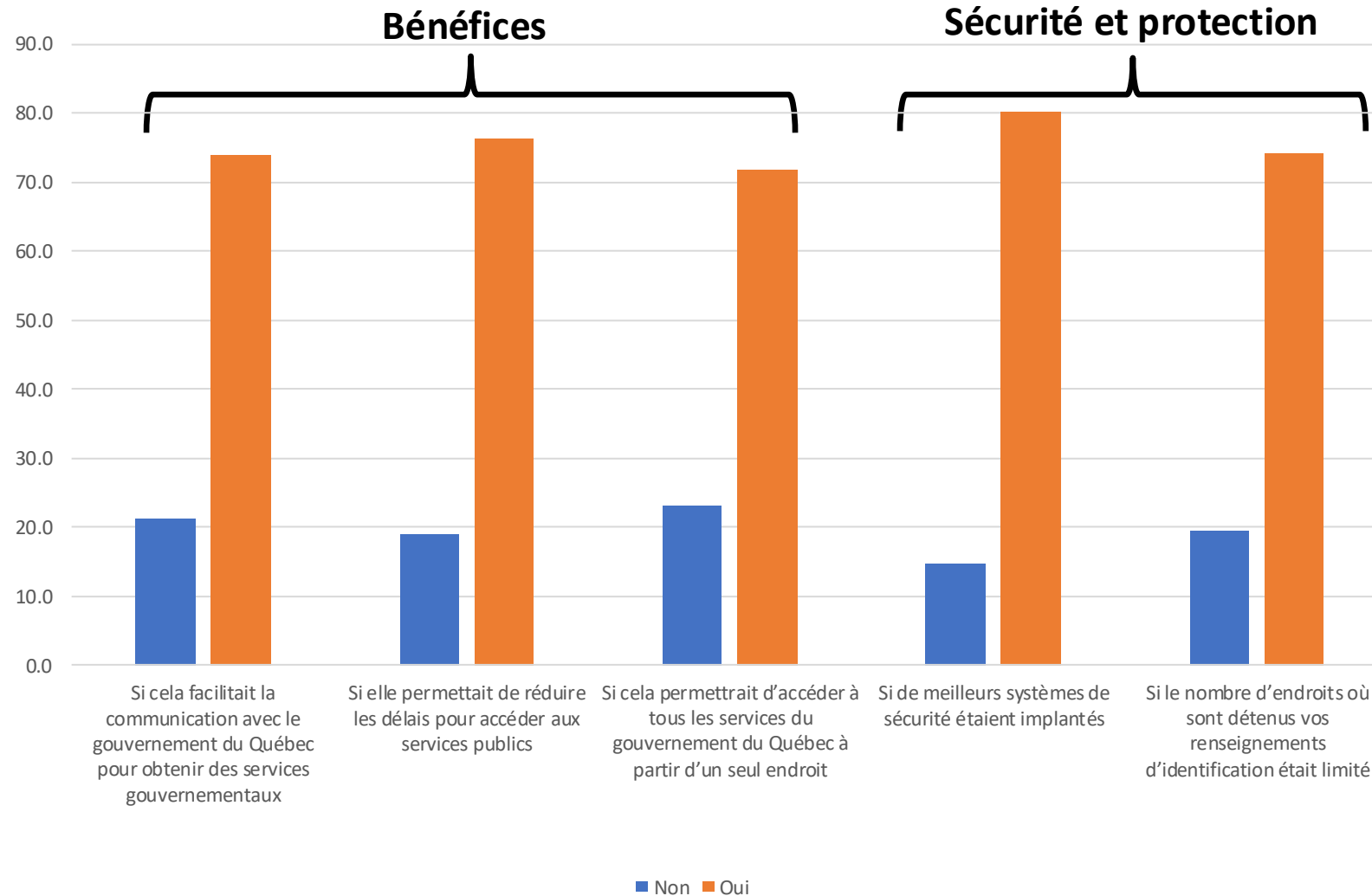
Degré d'ouverture pour l'utilisation de l'identité numérique (2024)

Résultats de recherches: perspectives et pratiques

Utilisation de l'identité numérique (2024)



Distribution (%) des répondants selon les conditions qui les rendraient favorable à
l'utilisation de l'identité numérique par le gouvernement



Résultats de recherches: perspectives et pratiques

Utilisation de l'identité numérique (2024)

Groupes de discussion (8)- à travers le Québec, 2024

Tableau 2
Types de risques (source : rapport SOM)

Renseignements personnels		Renseignements de santé	
Vol d'identité	Risques accrus pour l'identité, l'adresse, le compte bancaire, le NAS, et tout ce qui est lié au nom de la personne.	Intégrité des renseignements	Perte, vol ou partage non autorisé (ex. : vente de données à des compagnies pharmaceutiques)
Fraude et manipulation avec l'IA	Risque de fraude avec l'utilisation de l'IA (ex. : imitation de la voix pour obtenir des renseignements personnels).	Discrimination	Discrimination potentielle envers une personne sur la base de ses informations de santé par un employeur, un assureur ou un individu malveillant; un gestionnaire pourrait avoir accès à des informations sensibles lors d'une demande d'emploi.
Sécurité financière	Risque de « vidage » des comptes bancaires (avec des difficultés, pour les compagnies concernées, de rembourser); difficultés à rétablir un dossier financier après une tentative de fraude.	Impact financier	Primes plus élevées pour une assurance vie en cas de fuite de renseignements de santé non déclarés ou refus d'assurance; association erronée de problèmes médicaux non liés pouvant nuire à une demande d'indemnisation (ex. : CNESST).
Fuite et usage non autorisé	Utilisation non autorisée des données personnelles à des fins non consenties.	Fraude	Un individu malveillant pourrait utiliser les données d'une personne vulnérable pour l'extorquer ou pour lui vendre un produit.
Erreurs et risques liés à l'humain	Des erreurs d'authentification et des risques d'erreurs humaines accrus lorsqu'un grand nombre de personnes manipulent les données.	Diagnostic médical biaisé	Un médecin pourrait être influencé par les avis de ses confrères dans son diagnostic plutôt que se fier à ses propres observations.
Publicité et sollicitation	Profilage pour la publicité (ex. : sur les réseaux sociaux); sollicitation téléphonique et par courriel (ex. : pourriel)	Gestion des dossiers	Préoccupation liée au facteur humain, incluant la destination des dossiers, les personnes qui les consultent (ex. : par curiosité), et leur destruction inappropriée.

Résultats de recherches: perspectives et pratiques

L'ouverture des répondants face à l'usage de technologies d'information et de communication et à l'utilisation de leurs données personnelles par les gouvernements **n'est pas inconditionnelle**

Les gens sont toutefois **prêts à considérer une posture différente et changer d'idée** si des réponses sont apportées à certaines questions:

- quels bénéfices ?
- quel fonctionnement ?
- quelles garanties face à mes préoccupations?

Confiance aux intentions et à la motivation du gouvernement **mais** moins à sa capacité.

considérations

dimensions

technologique	fiabilité (<i>reliance</i>)
humaine	proximité ↗ confiance
organisationnelle	transparence

implications

Sécurité/protection est un enjeu majeur
Capacités technologiques gouvernementales
Communication publique
Déplacement des relations personnelles vers la fiabilité technologique

Exemples d'implications:

Objectif premier de l'implantation de technologies:

les répondants considèrent en grande majorité que l'implantation de nouvelles technologies devrait favoriser *l'efficience* dans leur travail et être moins liée aux caractéristiques innovantes de celles-ci. Il faut que cela contribue à optimiser les ressources telles que le temps, le matériel

Sur

Sur

la priorisation de la recherche d'efficience signale-t-elle un biais favorable au maintien de pratiques éprouvées, mais améliorées et possiblement au détriment de nouvelles manières de faire ?

Sur

Principal risque:

Sur les

un des risques relevés par les participants parmi les plus souvent évoqués a été:

- la sécurité et la confidentialité des données pour les médecins et les infirmières, ainsi que la dépendance à des systèmes sujets à des pannes, des piratages ou des dysfonctionnements, notamment liés à l'Internet pour les infirmières auxiliaires

Attitude du personnel clinique face à utilisation d'outils technologiques dans les établissements de santé au Québec (2025)

Daniel J. Caron, Alexandre Prud'homme, Roxanne Borgès-DaSylva et Maude Laberge CIRANO (2025)

Perspective citoyenne: générale

+

Attitude du personnel clinique face à utilisation d'outils technologiques dans les établissements de santé au Québec (2025) Caron, D. J., Prud'homme, A., La Dare, L. O., & Borgès da Silva, R. (2025) RP-27, Rapports de projets, CIRANO.) <https://doi.org/10.54932/ZSXK2570>

Et d'autres études.....

Perspective professionnelle

Perspective organisationnelle

Archivage médical dans un environnement numérique (Recherche en cours auprès du CHUM et du CHU de Québec)

Perspective citoyenne: usager

Gouvernance et gestion des données dans le secteur de la santé: revue de la littérature et considérations pratiques
Daniel J. Caron et Vincent Nicolini, CRERI, Juin 2022

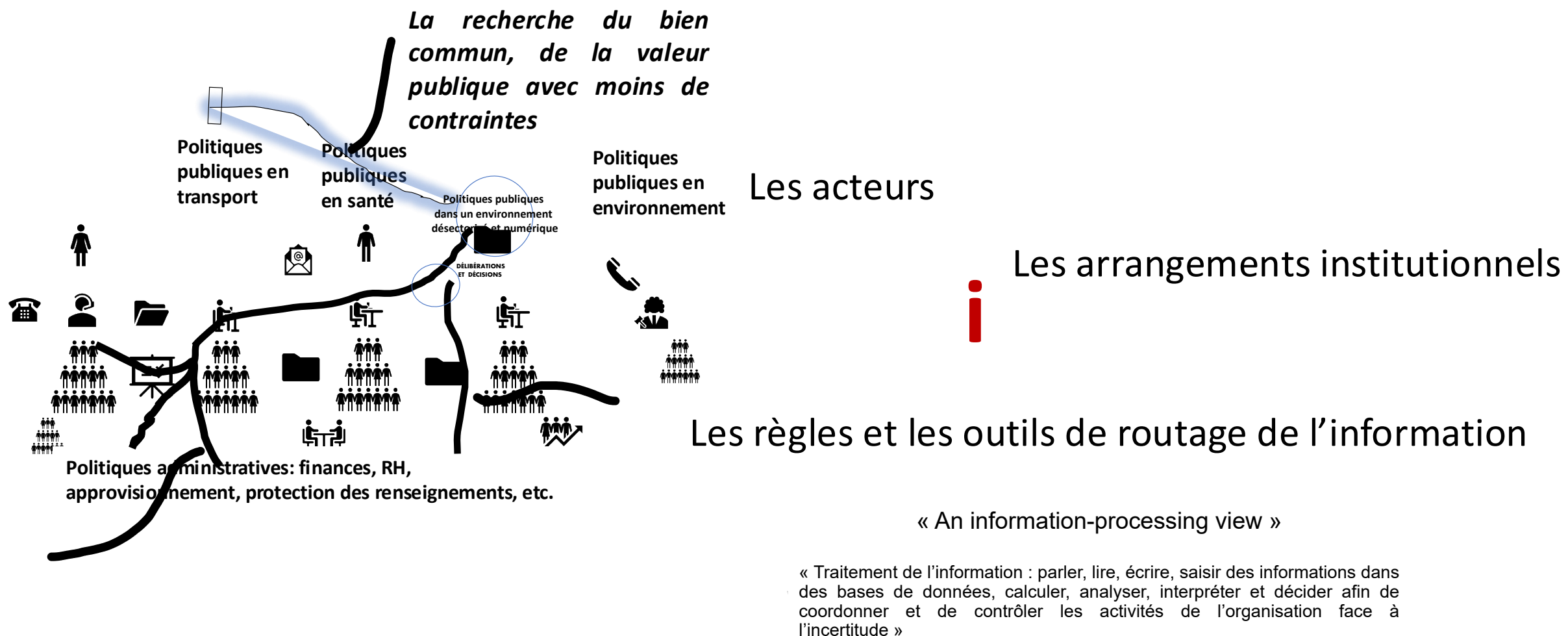
Et d'autres études.....

Autres acteurs.....

+

Etc.

Éléments de réflexion pour des politiques intégrées et cohérentes



usagers

Confiance

Processus d'apprentissage

Mesurer l'impact d'une fuite

Capacités

Continuer à identifier les
variables importantes
pour les citoyens-e.g. le
consentement

Motivation

Autres tiers

Analyse des intérêts
exprimés

Qui sont-ils?
Quelles responsabilités
(leur discours: volonté de
partage)?

But: compréhension et
visées partagées/opposées

Professionnels de la santé
Administrateurs
Plateformes
Etc.

Recherches en cours et à venir

adéquation

La mise en œuvre
Projets de loi, lois et
autres instruments de
politiques

Évaluation de mise en
œuvre

(1)

(2)

Conclusion

Le processus d'élaboration de politiques publiques, la dimension *substantielle* et *institutionnelle* de ces politiques et leur cohérence d'ensemble affecteront son contenu, son acceptabilité sociale et éventuellement la performance globale de l'initiative.

Dans quel intérêt? Qui perd? Qui gagne?

« Mais non, enfin! Réfléchis! Les cristaux ne soignent pas, ils *détectent*. En médecine comme ailleurs, c'est d'abord l'information qui compte. Mieux on comprend ce qu'il se passe, mieux on peut soigner. »

Fantastique histoire d'amour, Sophie Divry, Seuil 2024.



<https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/midi-info/segments/rattrapage/2075960/acces-a-premiere-ligne-diagnostics-et-solutions-avec-dre-sarah-bedard>

Quelques travaux

Caron, D. J., Prud'homme, A., Laberge, M., Dare, L. O., & Borgès Da Silva, R. (2025). *Attitude du personnel clinique face à l'utilisation d'outils technologiques dans les établissements de santé au Québec* (2025RP-27, Rapports de projets, CIRANO.) <https://doi.org/10.54932/ZSXX2570>

Caron et al. (2025) Le routage de l'information médicale et administrative dans l'univers numérique de la santé et des services sociaux et le rôle des archivistes médicaux, Cahier de recherche, CRERI.
https://www.crieri.org/_files/ugd/8c3d8e_84fff5d2849d40d99eb4debe6c7f06cd.pdf

Gusfield, J., (2009) *La culture des problèmes publics. L'alcool au volant : la production d'un ordre symbolique*, Economica, coll. « Etudes Sociologiques », 354 p.

Knoepfel, P., Larrue, C., Varone Frédéric, Savard Jean-François. (2015). *Analyse et pilotage des politiques publiques : France, Suisse, Canada. Québec* : Presses de l'Université du Québec.

Caron, D.J., Bernardi, S., et Nicolini, V., L'acceptabilité sociale du partage des données de santé : revue de la littérature, Rapport de recherche, CRERI, ENAP, 2020

Caron, D. J., Nicolini, V. et Prud'homme, A. (2023). Policy approaches for increasing participation with personal health information and data sharing (HIDS). *Canadian Health Policy*. <https://www.canadianhealthpolicy.com/product/policy-approaches-for-increasing-participation-with-personal-health-information-and-data-sharing-hids/>

Caron, D.J., Lamarche, P.-O. et Nicolini, V. (2025). *La confiance comme levier pour le partage des renseignements personnels et de santé : perspectives citoyennes*. Obvia-CRERI. <https://doi.org/10.61737/XOZU2116>

Platt, J. E., Jacobson, P. D., & Kardia, S. L. R. (2018). Public Trust in Health Information Sharing : A Measure of System Trust. *Health Services Research*, 53(2), 824-845.

Questions, remarques, commentaires?

Daniel J. Caron Ph D

Professeur

Chercheur et Fellow du CIRANO

Membre chercheur associé, Observatoire international sur les
impacts sociétaux de l'IA et du numérique (OBVIA)

Adjunct Professor, SPPA, Carleton University

Titulaire de la Chaire de recherche en exploitation des
ressources informationnelles

www.crieri.org

École nationale d'administration publique

Gatineau